



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : زينب محمود السيد العيسوي

العنوان : 00

المحافظة : القليوبية

تاريخ تسجيل الإستمارة : 05-10-2026

رقم البطاقة : 28101191403548 رقم التليفون : 01275395034

العمر (تاريخ الميلاد) : 19-01-1981 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

المقر بما فيه
التوقيع: (-----)

الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الأبحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني	الوظيفة: -----	التوقيع: -----
الاسم: د/ندى حسن	الوظيفة: -----	التوقيع: -----
الاسم: د/نرمين رمضان	الوظيفة: -----	التوقيع: -----

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
قسم : -----
جهة العلاج : -----
نفقات : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: زينب محمود السيد العيسى National ID: 28101191403548	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





Immunohistochemistry report

Report Number m4460

Female	الجنس	رئيسة محمود السيد العيسوي	اسم المريض
القاهر	العنوان	41 Y	العمر
28/08/2022 13:42	تاريخ استلام العينة		تاريخ أخذ العينة
01/09/2022 12:21	تاريخ التقرير	معهذ ناصر	عالمه المختار
		معهذ ناصر	شعبة

Primary Sample

Paraffin Block

Test

ER & PR & HER2 neu & Ki67 (ER&PR: Harvey scoring system -Her2neu: CAP scoring system)

Comment

Technique

sample recieved was treated by - CONFIRM anti-estrogen (ER) (SP1) Rabbit monoclonal primary antibody - CONFIRM anti-progesterone receptor (PR) (IE2) Rabbit monoclonal primary antibody
Sample recieved was treated by - VENTANA anti-HER2/neu (4B5) Rabbit monoclonal primary antibody using DAB Detection kit in ventana benchmark GX / XT
Sample recieved was treated by - CONFIRM anti Ki67 (30-9) Rabbit monoclonal primary antibody

Result

ER: moderate nuclear staining of > 60 % of tumour cells (core biopsy)
PR: moderate nuclear staining of 5 % of tumour cells (core biopsy)
HER2/neu protein over expression: NO membrane staining of tumor cells (core biopsy)
Ki67: positive nuclear staining of 15 - 20 % of tumour cells (core biopsy)

Referral Lab

Comment

Conclusion

R: POSITIVE (SCORE 7 / 8)
R: POSITIVE (SCORE 4 / 8)
ER2/NEU PROTEIN OVER EXPRESSION: NEGATIVE
Ki67: THE PROLIFERATION INDEX OF THE TUMOUR IS 15 - 20 %

Pathologist

التقرير ماهر

Lab Director

التقرير ماهر

Name: زينب محمود السيد عيسوي			
MR. : 4650			
Detailed Medical Report			
		السيد	
تحيّة طبية وبعد,,			
		إيماء للطلب المقدم من	
بشأن تقرير طبي للمريض			
رقم طبي:		بقسم:	
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته			
تاريخ وساعة الخروج :		تاريخ وساعة الدخول :	
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه			
The patient was staged with a right-sided breast malignancy, radiotherapy (RT) and magnetic resonance mammography (MRM) indicating T3 N5/14 disease. The treatment plan included adjuvant chemotherapy with ACTH (AC × 4 plus TXT × 2), followed by PORTH, and endocrine therapy comprising tamoxifen (TAM) combined with ZOLADEX. Subsequently, the regimen was transitioned to an aromatase inhibitor (AI) together with continued ZOLADEX. The current management consists of prescribing femara (letrozole) in combination with zoladex (goserelin). A follow-up appointment is scheduled for the clinic on 10/10, and the patient will receive additional zoladex. Pharmacy BSM has been requested to provide medication for the next two months.			
تحريراً في ,			
التاريخ :		19-09-2026	
الوقت :		نهى سعيد علي محمد	
الطبيب المعالج :			
يعتمد ,			

CHH ABHI ISHAK

Dr. CHH ABHI ISHAK, Pathology - Prof. of Pathology, Armed Forces Institute of Pathology, India
Member, United States Canadian Academy of Pathology

DR. CHH ABHI ISHAK

Dr. CHH ABHI ISHAK, Pathology - Ass. Prof. of Pathology, Harvard Medical School, Mass General Hospital, Harvard Medical School
Member, United States Canadian Academy of Pathology

Patient Name : زينة محمد العبدوي

Age : 41 Y 7 M 11

Referred By Prof. Dr. محمد العبدوي

Clinical Diagnosis : Right breast mass

Nature of Specimen : Right modified radical mastectomy

Receiving Date : 2022-09-08

Analysis ID :



64204

Gender : Female

Patient ID : 188

PATHOLOGY REPORT

Gross :

Right MRM specimen was received measuring 37x20x11 cm, covered by skin ellipse measured 25x18 cm.
Nipple and areola looked unremarkable grossly.
Serially revealed a mass with firm gritty cut section and ill defined borders measured 9.5x7.5x7cm, located just beneath the skin and 0.2 from the least surgical deep margin (taken).
Dissection of the axilla revealed 14 lymph nodes, the largest was 7.5x7x6.5cm, with gross white firm cut section.
Also received in the same container separated fibrofatty tissue piece measured 3.5x3x1.5cm, looked unremarkable grossly.

Microscopic :

Sections examined from specimen received revealed breast tissue showing tumour tissue formed of irregular groups of malignant ductal cells showing moderate to marked nuclear pleomorphism & hyperchromasia.
There is poor attempts at tubular formation.
There is moderate number of mitotic figures.
There is moderate desmoplasia and moderate tumoral necrosis.
There is peritumoural lymphocytic infiltration around 25%.
Lympho-vascular space invasion is present.
Perineural invasion is present.
No intraductal component.
Sections from the nipple and areola are free. Skin covering is free.
Surgical margins are free. Separate fat is free.
Sections examined from the axillary nodes revealed metastatic deposits in 3 out of 14 nodes with capsular infiltration. L.N (5/14).

زينة محمد العبدوي - 41 سنة 7 أشهر 11 يوم - 2022-09-08 - 188 - 64204

Elia Anis Ishak

Dr. Elia Anis Ishak, Pathology - Prof. of Pathology - Cairo University
Fellow, Armed Forces Institute of Pathology, USA
Member, United States Canadian Academy of Pathology

Shady Elia Anis

Dr. Shady Elia Anis, Pathology - Ass. Prof. of Pathology, Cairo Univ.
Fellow, Mass General Hospital, Harvard, USA
Member, United States Canadian Academy of Pathology

Patient Name : زينة محمود السيد الشاذلي

Age : 41 Y 7 M 1 D

Referred By Prof. Dr. : محمد العزيم

Clinical Diagnosis : Right breast mass

Nature of Specimen : Right modified radical mastectomy

Receiving Date : 2022-09-08

Analysis ID : 682099

Gender : Female

Patient ID : 166

PATHOLOGY REPORT

Diagnosis :

Right modified radical mastectomy,
INFILTRATING DUCT CARCINOMA GRADE III, NO INTRADUCTAL COMPONENT, FREE
SURGICAL MARGINS, POSITIVE METASTATIC DEPOSITS IN FIVE LYMPH NODES, LN
(5 / 14), WITH EVIDENCE OF CAPSULAR INFILTRATION
TUMOR STAGE: pT3, pN2a.

Prof. Dr. Shady Elia Anis

Prof. Dr. Elia Anis Ishak

Shady Elia Anis

Elia Anis

For more information, please contact the laboratory or visit our website.

شماره رجسٹریشن : ٢٥٧٩٨٩٥٥ - ٢٥٧٩٨٩٥٥ - ٢٥٧٩٨٩٥٥
تلفون : ٢٥٧٩٨٩٥٥ - ٢٥٧٩٨٩٥٥ - ٢٥٧٩٨٩٥٥

Name: Mrs. Zeinab Mahmoud Alsayed

Date: 10 /08 / 2022

Ref Prof Dr Edward Ayoub

Bilateral Mammographic Examination with Complementary Ultrasound for the Breasts Revealed:

I. Clinical status :

Right breast swelling and pain .

II. Findings:

- Dense fibroglandular architecture of the breast. (ACR c)
- A large irregular speculated soft tissue density is seen in the upper inner quadrant of the right breast at 2 o'clock with thin tentacles radiating from its outer margins causing focal parenchymal distortion.
- Complementary US examination revealed the hypoechoic solid texture of the mass lesion measuring 7.6 x 7.4 cm in diameters causing skin retraction . Color Doppler imaging revealed central vascularity with high RI = 0.69
- No plemorphic clusters of microcalcification could be seen within the mass lesion .
- Enlarged right axillary lymph nodes measuring 6.0 x 2.7 cm with hypertrophied cortex .
- Normal appearance of the left breast with intra-mamary lymph node is noted measuring 9 x 5 mm in diameter with preserved hilum .

CONCLUSION:-

- Findings are those of neoplastic breast soft tissue mass lesion of the right breast with axillary nodal infiltration .(BIRADS 5), for US guided core needle biopsy.

Definition of Breast Imaging Reporting and Data System (BIRADS)

- 1) Normal
- 2) Benign
- 3) Probably benign
- 4) Probably malignant
- 5) Malignant

Dr. Manal Halim, MD
Prof of radiodiagnosis , Cairo University

المركز الرئيسي / ٢٨ شارع روض الفرج - شبرا - القاهرة

تليفون : ٢٤٣٢٠٨٥٠ - ٢٤٣٠١٢٩٧ - ٢٤٣٠١٢٩٠ فاكس : ٢٤٣٢٣٨٥٥ موبايل : ٠١٢٨٩٣٠٢٢٢٦

فرع المهندسين / بالمستشفى الدولي للكلية والمسالك البولية

شارع ميدان المدني من شارع السودان - المهندسين / تليفون ٣٣٠٥٢٠٠٠ موبايل : ٠١٠٠٨٤٤٣٣٦٩

Omegascan.sh@gmail.com

Nuclear Medicine Unit

Patient Name: Zainab Mahmoud Alsaeld

Date: 13/10/2024

Referring physician: Prof.

^{99m}Tc-MDP BONE SCAN

Desired information: skeletal surveying to detect multiple lesions.

Technique: Anterior and posterior whole-body scan performed 2 hours after I.V administration of 20 mCi ^{99m}Tc-MDP:

Report:

- No definite active hot spot that could account for osseous metastatic lesions .
- Spondylodegenerative changes are seen at dorso / lumbar vertebrae .
- Osteoarthritic changes are seen at both shoulders , both knees .
- Both kidneys are normally seen.

Conclusion:

The surveyed skeleton is free of any osseous metastatic lesions

Thanks for the referral

Nuclear Medicine Unit

DR. Sherin Mahdy, MD

DR/ Mohamed Emam



مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

البيانات الشخصية
بطاقة
مريض

MDT FORM

/ / 20

G

Name	اسم المريض	MRN	13531-03
Age	43	ID	
Menopausal status		Phone	012112-8972
NRS SCORE		Marital status	
BMI		Family history	1278747010
CO morbidity		REASON OF MDT	

Clinical Data

BX:

ER:

2/8

PR:

4/8

HER 2:

-ve

KI67:

15-20%

Sonomammography:

Mets Workup:

R

2/9/1

L



T N M

Recommendations:

She underwent 9/2022 B-MRM : T3N1/14
Received 4-AC + 2 TXT + 1cm PORT-H
3/2023 Started Tam/Zoladex.
She wants to continue Adjuvant as in Her 1

MDT OUTCOME & PLAN

Continue tam-zoladex For 1 year
then shift to AI zoladex

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric